Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Bagé

Rua Bento Gonçalves, 499, Direita - Bairro: Centro - CEP: 96400900 - Fone: (53) 3036-8494 - Balcão Virtual (53) 99709-1542 - Email: frbage3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007486-40.2024.8.21.0004/RS

AUTOR: TATIANE PINTO DOMINGUES

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

TATIANE PINTO DOMINGUES ajuizou *ação de obrigação de fazer* contra **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** (evento 1, INIC1). Sustentou o objetivo de obrigar a ré ao custeio de tratamento médico ambulatorial com o medicamento Benlysta (Belimumabe) 200 mg, indicado para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID 10 M32.1), conforme prescrição médica da autora. Afirmou que o medicamento foi inicialmente negado pela operadora de plano de saúde, sob o argumento de que não consta no rol da ANS e que, em caso de tratamento domiciliar, a cobertura não seria devida. Em sede de tutela de urgência, postulou para fins de obrigar a ré a custear o tratamento ambulatorial, uma vez por semana por tempo indeterminado. Ao final, postulou pela procedência dos pedidos para fins de tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência, sendo forncecido medicamento suficientes para 3 (três) meses do tratamento, por tempo indeterminado. Requereu o benefício da gratuidade judiciária. Juntou documentos.

Deferido o benefício requerido, bem como a tutela de urgência e determinada a citação da ré (evento 4, DESPADEC1).

Citada (evento 11, PROC1), a ré apresentou contestação (evento 12, CONT1). Em sede de mérito, alegou que o medicamento não se encontra previsto no rol de procedimentos da ANS para a situação da autora e que, em se tratando de medicamento para uso domiciliar, seria lícita a recusa de cobertura. Ao final, postulou pela improcedência do pedido autoral.

Houve réplica (evento 15, RÉPLICA1).

Saneado o feito, sem preliminares ou questões processuais pendentes de análise, as partes foram intimadas acerca das demais provas que pretendiam produzir (evento 17, DESPADEC1).

As parte requeram o julgamento antecipado do feito (evento 21, PET1/evento 22, PET1).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre observar que a matéria em questão envolve a cobertura de tratamento médico por parte de plano de saúde, com base nos direitos previstos na Constituição Federal e na Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).

A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 196, o direito à saúde como direito fundamental, determinando que o Estado deve garantir acesso universal e igualitário aos serviços e ações necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Esse direito é, inclusive, ampliado em relação aos beneficiários de planos de saúde privados, pois a Lei 9.656/98 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura para os procedimentos médicos que sejam necessários e prescritos pelo médico.

Diante disso, o art. 10, da Lei 9.656/1998 assim estabelece:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*

Assim, os planos privados de saúde devem ter a ANS como referência básica e, em casos de medicamento ou procedimento que não conste no rol referido, pode este ser autorizado, desde que preencha alternativamente os requisitos do artigo §13, I ou II.

Colaciono o dispositivo supramencionado:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Contudo, a jurisprudência efetivando diálogo entre a norma da Lei 9.656/1998 e o art. 47, do Código de Defesa do Consumidor tem assim se manifestado reiteradamente. Cito jurisprudência abaixo:

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL . DANO MORAL. 1. De acordo com a interpretação do art. 10, VI, e do art . 12, I, 'c', II, 'g', da Lei n. 9.656/98, as operadoras de planos de saúde estão dispensadas de fornecer medicamentos de uso domiciliar, exceto antineoplásicos e medicamentos de uso em home care. Outrossim, presente o teor do art . 10, VI, e o disposto no art. 47 do CDC, segundo o qual o contrato deve sempre ser interpretado favoravelmente ao consumidor, a limitação de cobertura não abrange medicamentos de uso ambulatorial, hipótese em exame. 2. O dano moral, contudo, não se caracteriza, uma vez que a recusa da operadora está fundamentada, não se revelando arbitrária, nem de todo insustentável ou ofensiva às disposições legais/contratuais . O fato de a operadora ter sido condenada na obrigação de fazer, à luz da interpretação do julgador, não pode ser admitido como caracterizador de conduta ilícita para fins de responsabilidade civil. Responsabilidade da ré que se limita ao âmbito da execução do contrato. Precedentes do STJ. 3 . Sentença confirmada. Base de cálculo da verba honorária bem estabelecida, na origem. Honorários recursais devidos. APELAÇÕES DESPROVIDAS . (Apelação Cível, Nº 51984489720228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 27-03-2024)"

No caso em análise, a autora é beneficiária do plano de saúde da ré, e o tratamento médico requerido foi indicado por médico especialista e credenciado, que prescreveu o medicamento Benlysta (Belimumabe), aprovado pela ANVISA e indicado para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico.

Ainda, ressalta-se que o medicamento é de uso ambulatorial, como referido pela própria ré em sua negativa, afirmando que o medicamento se tratava de uso ambulatorial. Não restando, assim, falar em restrição à disponibilização.

A negativa de cobertura apresentada pela ré é, portanto, incompatível com a legislação e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA AUTOIMUNE GRAVE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. SUPERVISÃO
DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. No caso em exame, o medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento de Lúpus Erimatoso Sistêmico é de uso intravenoso e, portanto, de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, exigindo administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual a negativa de cobertura é indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 02/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/10/2020 e atribuído ao gabinete em 17/03/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento para tratamento domiciliar (Ferinject 1000 mg - carboximaltose férrica), não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prescrito para doença (anemia grave por deficiência de ferro) cuja cobertura está prevista no contrato. 3. No julgamento da ADI 2.095/RS (Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), o Plenário do STF decidiu que "o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência"; assim sendo, os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e com a legislação infraconstitucional pertinente (CDC e CC), não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. 4. Se a Lei 9.656/1998 estabelece que todas as doenças classificadas na CID estão incluídas no plano-referência, só se excluem da cobertura aqueles procedimentos e eventos relativos aos segmentos não contratados pelo consumidor, nos termos do art. 12, além das exceções legais declinadas nos incisos do art. 10, sendo vedado à operadora, para justificar eventual negativa de cobertura, alegar outras hipóteses de exclusão inseridas no contrato ou em normas regulamentares, mas que sejam ofensivas à lei. 5. Não cabe a ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano-referência, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao pleno tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada. 6. Seja sob o prisma do CDC, ou mesmo do CC/2002, não há como exigir do consumidor/aderente, no momento em que decide celebrar o contrato de plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os eventos e procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos para cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde. 7. Considerar a natureza taxativa do rol da ANS é demandar do consumidor/aderente um conhecimento técnico que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; é criar impedimento inaceitável de acesso do usuário às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas

pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; é, pois, conclusão que agrava a condição de vulnerabilidade do consumidor/aderente porque lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida. 8. Quando se trata de saúde suplementar, há, no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, uma limitação legal da cobertura obrigatória oferecida que autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, desde que prévia e devidamente informado o consumidor/aderente acerca dessa restrição, nos termos do CDC e do CC/2002. 9. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar.10. Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.11. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

Ademais, até mesmo em medicamentos de uso domiciliar, a jurisprudência tem ressalvado a possibilidade de fornecimento em se tratando de medicamentos antineoplásicos orais (e correlacionados); a medicação assistida (*home care*); e os incluídos no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) para esse fim, que dirá em medicamento de uso ambulatorial.

De acordo com a jurisprudência do STJ, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida ("home care") e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 2.071.979/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024 e AgInt no AREsp n. 1.771.350/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem se posicionado de forma similar, reconhecendo a obrigatoriedade dos planos de saúde em fornecer os medicamentos necessários para o tratamento de doenças graves, independentemente de sua inclusão no rol da ANS.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO VIA INFUSÃO. BELIMUMABE (BENLYSTA). NEGATIVA DE COBERTURA. ADVENTO DA LEI Nº 14.454/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida na origem, nos autos da obrigação de fazer na qual restou indeferido o pedido de fornecimento do tratamento com a terapia imunobiológica endovenosa, com o fármaco Belimumabe (Benlysta). Referiu que foi diagnosticada com Lúpus eritematoso disseminado sistêmico (CID 10 M32.1). Ao atender o comando do art.197 da Carta Constitucional a Lei n. 9656/98, disciplinou os planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de complementar o Sistema Público Saúde (SUS). Com esse propósito foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), via Lei n.9961/00, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa.Imprescindível considerar que afora a instituição do Plano-Referência de Assistência à Saúde, forte no art.10 da Lei n.9656/98, que garante o mínimo assistencial de caráter negocial privado, há, igualmente, a faculdade de o consumidor contratar plano de assistência à saúde de natureza superior e com maior cobertura, consoante faculta o art.12 do mesmo Diploma Legal. Ambos são regulados pela ANS, a diferença é o valor da contraprestação, o que infirma concluir que é inexorável considerar a natureza da negociação e a espécie de plano assistencial privado em litígio. Recentemente, especificamente na data de 21 de setembro de 2022, sobreveio a publicação da Lei Federal nº 14.454, que alterou a Lei Federal nº 9.656/1998, especialmente, acrescentou os parágrafos 4º, 12 e 13 ao artigo 10, a qual ampliou a cobertura dos tratamentos de saúde, viabilizando sua concessão mesmo que não prevista no Rol da ANS, mas desde que obedeça os requisitos nela impostos sic: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." No caso telado vislumbro que a parte autora necessita realizar tratamento com a terapia imunobiológica endovenosa, com o fármaco Belimumabe (Benlysta). Referiu que foi diagnosticada com Lúpus eritematoso disseminado sistêmico (CID 10 M32.1), o qual, diante da gravidade e ineficácia dos tratamentos outrora utilizados, necessita de de terapia específica acima referida. Por conseguinte, não estando no rol como de cobertura obrigatória, deve haver demonstração da eficácia do tratamento, nos termos do art. 10, §13 da Lei 9.565/98, alterado pela Lei nº 14.454/2022. Em que pese a decisão do magistrado a quo, verifico que, há nota técnica do E-NatJus, nº 83564, identificando como favorável o uso do medicamento para a moléstia da parte autora, evento 1, OUT21Considerando considerando nota técnica favorável do E-NatJus, bem como a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.454/2022, vislumbro que a parte autora comprovou os requisitos, excepcionais para a concessão da medicação postulada.Ressalto, ademais, que tal flexibilização também se deve ao fato de que o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento/medicamento/exame, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52108211820228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23-06-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. RITUXIMABE 500MG. REFORMA DA DECISÃO DA ORIGEM. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. ADEMAIS, NÃO CABE AOS PLANOS DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO OU O NÚMERO DE SESSÕES, INCUMBÊNCIA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA, DETENTOR DO CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA MELHOR CONDUZIR O TRATAMENTO DE SEUS PACIENTES, SOBRETUDO PELA PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE EM CONFLITO COM DEMAIS INTERESSES. CONTEXTO EM QUE LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS INFORMA A NECESSIDADE DA PACIENTE EM UTILIZAR O FÁRMACO RITUXIMABE 500MG, RESSALTANDO SER ESSA A MELHOR ALTERNATIVA APRESENTADA NO MOMENTO, JÁ QUE A AGRAVANTE JÁ FEZ USO DE OUTRAS MEDICAÇÕES, HAVENDO EFICÁCIA PARCIAL OU MELHORA SOMENTE TEMPORÁRIA. ADEMAIS, SEGUNDO O LAUDO, SEM O FÁRMACO, PODE HAVER PIORA DE MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS - AGRAVAMENTO DE PLAQUETOMIA COM POSSÍVEIS SANGRAMENTOS; PIORA DE LEUCOPENIA COM RISCO DE INFECÇÕES; PIORA DE NEFRITE COM PERDA DE FUNÇÃO REAL QUE, SE AGRAVADA, PODE LEVAR A NECESSIDADE DE DIÁLISE. MEDICAMENTO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA E ESTÁ ELENCADO COMO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO ROL DE EVENTOS EM SAÚDE DA ANS (RESOLUÇÃO N. 465/2021/ANS), NÃO SE SUSTENTANDO A NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51827815520248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 25-09-2024

Outro ponto relevante é a eficácia do tratamento com o medicamento Benlysta, que foi comprovada por parecer médico e por dados técnicos. O fármaco é aprovado pela ANVISA para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico e foi recomendada pela NICE (Agência Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde da Inglaterra), que o considera uma opção terapêutica para casos de alta atividade da doença, como é o caso da autora. Conforme regulamentação:

Detalhe do Produto: BENLYSTA					
Nome do Produto	BENLYSTA	**Complemento da Marca**		**Número do Processo**	25351.699419/2010-15
Número da Regularização	101070295	**Data da Regularização**	12/11/2012	**Vencimento da Regularização**	11/2027
Empresa Detentora da Regularização	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	**CNPJ**	33.247.743/0001-10	**AFE**	1.00.107-1
Princípio Ativo	belimumabe			**Categoria Regulatória**	Biológico
Medicamento de referência	-				
Classe Terapêutica	IMUNODEPRESSOR			**ATC**	
Tipo de Priorização	Ordinária	**Parecer Público**	-		
Bulário Eletrônico	Acesse aqui	**Rotulagem**			

4	200 MG/ML SOL INJ CT 4 SER PREENC VD TRANS X 1ML Ativo	1010702950044	Solução Injetável	12/11/2012	36 meses

Portanto, considerando a prescrição médica, a comprovação da eficácia do medicamento, a aprovação da ANVISA, a jurisprudência dos tribunais e a legislação aplicável, não há fundamento para a negativa do plano de saúde.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONFIRMO** a tutela deferida no evento 4, DESPADEC1 e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **TATIANE PINTO DOMINGUES** contra **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA,** para fins de determinar que o custo do tratamento ambulatorial com o fornecimento do medicamento Benlysta (Belimumabe), na dose de 200mg/ml, uma vez por semana, pelo tempo determinado por profissinal competente, conforme prescrição médica.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. PROVIMENTOS FINAIS

Oposto(s) recurso(s) de embargos de declaração, venham conclusos os autos para análise dos pressupostos recursais e eventual necessidade de garantir-se o contraditório.

Outrossim, tendo em vista que o §3º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, caso interposto recurso de apelação, caberá ao Cartório abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de recurso adesivo (artigo 1.010, § 2º, do Código de Processo Civil) e impugnação de decisão interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação (artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil).

Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos imediatamente ao Tribunal de Justiça.

Sentença publicada e registrada, eletronicamente, nesta data.

Intimações eletrônicas agendadas.

Documento assinado eletronicamente por **EMANUELLE MASSING STEFANI, Juíza de Direito**, em 25/07/2025, às 17:29:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10072436350v21** e o código CRC **7ff1936f**.